

Datos Personales							
Nombre:	MARIA ISABELLA PEÑALOZA RUEDA	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2013-04-11	Edad	13 Años, 0 Meses, Y 13 Días
Identificación:	TI - 1067621984	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Lruedalopez54@gmail.Com - 1067621984			Dirección:	Manzana D Casa 49 Conjunto Cerrado Florez De Maria 2		
Departamento:	CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		YEIMIS RUEDA - Parentesco (tio) - Teléfono (3246748675)					

Apertura psicología del 2026-04-19 22:19:16: 13 años, 0 meses, y 13 días

DATOS GENERALES

Remisión

Autorreferido (Particular)

DX principal

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 1

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 2

NREF - NO REFIERE

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

“Yo soy la tía, la mamá siempre ha estado desprendida de ella, el papá está atento económicamente pero afectivamente no” “Ella no ve su cuerpo con valor, ya ha tenido novio, en el colegio nos llamaron que estaba besándose con un chico, que se dejaba manosear”.

Enfermedad Actual

La paciente adolescente de 13 años presenta un cuadro de alteraciones emocionales y conductuales caracterizado por dificultades en la regulación afectiva, necesidad marcada de validación externa y conductas de búsqueda de atención. Según lo reportado por la familia, se evidencian comportamientos asociados a exposición corporal inapropiada para su edad, tendencia a vincularse con pares de mayor edad y conductas de tipo seductor, lo cual podría estar relacionado con una necesidad significativa de afecto y reconocimiento. Estas manifestaciones se han intensificado desde el año 2025.Se observan dificultades en la dinámica relacional, incluyendo conductas de confrontación hacia la hermana, con intentos de descalificación frente a terceros. Asimismo, se reportan comportamientos de oposición, posibles distorsiones en la comunicación y búsqueda constante de atención.

La paciente refiere sentimientos persistentes de soledad, percepción de falta de afecto y baja valoración personal, expresando que “nadie la ama” y que solo se siente querida por dos figuras específicas "la prima Ximena y Salma".

Se identifican verbalizaciones de ideación suicida pasiva, manifestando que, de tener la oportunidad, atentaría contra su vida, lo cual constituye un indicador clínico de alto riesgo que requiere atención prioritaria. En relación con las figuras parentales, la paciente expresa percepción de rechazo por parte del padre y una mayor necesidad de contacto y validación afectiva por parte de la madre, evidenciando posibles dificultades en el apego y en la construcción de vínculos seguros.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

Intervención Quirúrgica Por Masa En Región Del Hombro (sin Complicaciones Reportadas)

Tóxicos

Traumáticos

Ninguno

Medicación

No Refiere

Paraclínicos

Ecografías,Resonancias

Hospitalizaciones

Si, Hipersensibilidad A Factores Ambientales (polvo, Ácaros).

Patología

No Refiere

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo

30 Años

Enfermedades De La Madre

No

Único Embarazo

2do

El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica

Si

Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo

No

Estado De La Madre Durante El Embarazo

Emociones Alteradas

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea Cesárea Anterior
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer No Refiere
Talla Al Nacer No Refiere	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido No Refiere
--

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 2M	Rolado 3M
Sedente Solo 4M	Gateo 6M
Bípodo Sin Ayuda 8M	Marcha 9M
Lenguaje Verbal 10M	Lenguaje Verbal Fluido 24M

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad Abuelo Paterno,Tío Paterno
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Cáncer De Seno	Otros No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa La paciente cursó estudios en el Colegio Chicos Ingeniosos hasta el año anterior, institución de la cual fue retirada debido a dificultades conductuales reportadas en el contexto escolar. Actualmente se encuentra matriculada en el Colegio Real de la Costa, donde cursa grado séptimo. Su rendimiento académico es descrito como regular, evidenciando mayor interés y desempeño en las asignaturas de ciencias naturales y química, y menor motivación hacia matemáticas e inglés. Se sugiere continuar el seguimiento del proceso de adaptación escolar y del comportamiento en el aula, con el fin de identificar posibles dificultades asociadas a la regulación conductual y al desempeño académico.
Historia laboral No refiere
Historia familiar La paciente reside actualmente con sus abuelos maternos, el Sr. Jaime Ruedas (52 años) y la Sra. Elida López (56 años), quienes mantienen una relación conyugal estable y funcional. En la dinámica familiar se evidencian dificultades en la interacción entre la paciente y sus cuidadores, asociadas a conflictos recurrentes derivados de comportamientos reportados como inusuales y desafiantes. La paciente refiere una relación ambivalente con los abuelos, manifestando inconformidad frente a los llamados de atención y normas establecidas en el hogar. En el vínculo fraterno, se observan conductas de confrontación hacia su hermana, incluyendo intentos de descalificación en contextos sociales, mediante comentarios relacionados con su apariencia e higiene personal. A nivel comportamental, se identifican conductas asociadas a búsqueda de reconocimiento y validación externa, tales como el interés marcado por la apariencia física (uso de maquillaje) y conductas orientadas a captar la atención de su entorno.
Historia social En el ámbito social, la paciente muestra variabilidad en su comportamiento según el contexto. En entornos familiares, tiende a presentar una actitud de retraimiento, con escasa participación, lenguaje no verbal asociado a incomodidad (gestualidad de desagrado) y preferencia por el aislamiento durante las interacciones. Asimismo, se observa baja disposición hacia el intercambio con miembros de la familia, manifestando desacuerdo o resistencia frente a dichos espacios. En contraste, en contextos sociales extrafamiliares, la paciente evidencia mayor nivel de interacción, logrando comunicarse de manera más espontánea, participar activamente en conversaciones, expresar afecto mediante la risa y establecer vínculos con mayor facilidad.
Historia emocional/afectiva

A nivel socio-afectivo, la paciente presenta variabilidad en la expresión emocional según el contexto relacional. En el núcleo familiar cercano, se describen manifestaciones de afecto y cercanía; sin embargo, con otros miembros de la familia extensa se evidencian cambios en la actitud, con mayor distanciamiento y menor expresividad emocional. En el contexto de pares, la paciente se muestra sociable, con conductas de amabilidad y adecuada interacción, logrando establecer vínculos con relativa facilidad.

Historia deportiva

La paciente participó en actividad deportiva (patinaje) durante un periodo aproximado de un año y seis meses. Posteriormente, abandonó dicha práctica por pérdida de interés, sin evidenciar continuidad en otras actividades deportivas estructuradas.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial

Se realizó entrevista semiestructurada con la tía en calidad de acudiente, con el fin de explorar la red de apoyo y las áreas funcionales de la adolescente, evidenciándose preocupación por parte del sistema familiar y disposición para el acompañamiento terapéutico.

Asimismo, se llevó a cabo exploración directa con la paciente y aplicación de instrumentos psicométricos basados en el modelo de Aaron T. Beck, obteniéndose los siguientes resultados: Inventario de Depresión de Beck (BDI) con puntaje de 43, indicativo de depresión grave, e Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) con puntaje de 20, correspondiente a ansiedad moderada.

Se aplicó adicionalmente el Test de la Familia, en el cual se evidencian indicadores proyectivos asociados a dificultades en la dinámica familiar, posibles conflictos en los vínculos afectivos y percepción de distanciamiento emocional respecto a figuras significativas, así como una organización jerárquica que sugiere vivencias internas relacionadas con la posición que ocupa dentro del sistema familiar. El dibujo proyecta una estructura familiar centrada en figuras sustitutas (abuelos) y en el vínculo fraterno, con ausencia de figuras parentales significativas, lo cual puede estar relacionado con vivencias de carencia afectiva o distanciamiento emocional. Se observa una jerarquización donde la figura de la hermana adquiere mayor relevancia, sugiriendo posibles dinámicas de rivalidad, comparación o conflicto. La distribución espacial y el tipo de trazo indican posibles dificultades en la integración afectiva del sistema familiar, así como necesidades de reconocimiento y validación emocional.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

No refiere

Intervención neurológica

No refiere

Intervención neuropsicológica

No refiere

Otras intervenciones

No refiere

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

La paciente ingresa a consulta de manera independiente, con actitud colaboradora y saludo adecuado al contexto. Presenta apariencia acorde a su edad y condiciones del entorno.

Se observa actitud general de retraimiento, con disminución del contacto visual, postura corporal asociada a inseguridad y tono de voz bajo. A nivel afectivo, se evidencia afecto deprimido, con expresión emocional restringida, predominando tristeza y desánimo. En cuanto al estado de ánimo, la paciente refiere sentimientos persistentes de tristeza, soledad y desvalorización personal, compatibles con sintomatología depresiva. Se identifican además manifestaciones de anhedonia e irritabilidad, especialmente en el contexto familiar. El lenguaje es coherente, de curso lento, con baja espontaneidad, sin alteraciones formales. El pensamiento es lógico, organizado y sin presencia de ideas delirantes. No se evidencian alteraciones en la sensopercepción (niega alucinaciones). A nivel cognitivo, se encuentra orientada en las esferas autopsíquica y alopsíquica, con atención y memoria conservadas. Se identifican verbalizaciones de ideación suicida sin planificación estructurada ni intentos previos, lo cual constituye un indicador de riesgo que requiere seguimiento clínico continuo. El juicio de realidad se encuentra conservado, así como la capacidad de introspección, evidenciando conciencia del malestar psicológico y del impacto de su estado emocional actual.

Ciclos del Sueño

La paciente presenta un patrón de sueño parcialmente conservado, con horario habitual de descanso entre las 8:30 pm y las 05:00 am. No obstante, refiere dificultades ocasionales en la conciliación del sueño y despertares nocturnos, ante los cuales intenta retomar el sueño de manera voluntaria.

Apetito

Se encuentra globalmente conservado; sin embargo, se observan conductas alimentarias variables, en ocasiones asociadas a búsqueda de atención. Presenta selectividad alimentaria, con preferencia por alimentos como frutas, pollo, carne, cerdo, pescado, arroz y cereales, y rechazo hacia algunos alimentos específicos (atún, yuca, salmón y ciertas verduras).

Actividades de Autocuidado

La paciente es independiente en la realización de actividades básicas de autocuidado, acordes a su edad.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F322 - EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS

Impresión Diagnóstica Relacionada 1

Z638 - OTROS PROBLEMAS ESPECIFICADOS RELACIONADOS CON EL GRUPO PRIMARIO DE APOYO

Impresión Diagnóstica Relacionada 2

NREF - NO REFIERE

Establecido por primera vez

Si

Objeto de atención clínica

No refiere

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Disminuir la sintomatología depresiva y el riesgo emocional asociado, fortaleciendo la regulación emocional, la construcción de vínculos seguros y las estrategias de afrontamiento adaptativas en la paciente.

Objetivos Específicos

- Favorecer la identificación, expresión y validación de las emociones.
- Disminuir pensamientos disfuncionales asociados a desvalorización y soledad.
- Intervenir la ideación suicida mediante estrategias de contención emocional y monitoreo continuo.
- Fortalecer habilidades de regulación emocional y tolerancia al malestar.
- Reducir conductas de búsqueda de atención mediante el desarrollo de estrategias adaptativas de vinculación.
- Mejorar la dinámica familiar mediante psicoeducación y orientación a cuidadores.
- Promover el fortalecimiento de la autoestima y la identidad personal.
- Fomentar actividades reforzantes (activación conductual).
- Mejorar habilidades sociales y vínculos seguros con pares.

Sugerencias e Interconsultas

- Psiquiatría Infantil (Se sugiere valoración por psiquiatría infantil para evaluación de necesidad de manejo farmacológico, dada la severidad del cuadro depresivo y la presencia de ideación suicida).

Observaciones y Recomendaciones

OBSERVACIONES

- La paciente presenta un cuadro de alta vulnerabilidad emocional, evidenciado en sintomatología depresiva severa, ideación suicida y marcada necesidad de validación afectiva.
- Se identifican dificultades en la dinámica familiar, particularmente en la relación con figuras de cuidado, lo cual actúa como factor mantenedor del malestar emocional.
- La presencia de recursos cognitivos conservados y capacidad de introspección constituyen factores protectores importantes; sin embargo, la intensidad del malestar emocional requiere intervención clínica estructurada y seguimiento continuo.
- Se observa discrepancia entre el funcionamiento social externo (adecuado con pares) y el contexto familiar, lo cual sugiere la presencia de conflicto vincular significativo.

RECOMENDACIONES

- Continuar proceso psicoterapéutico con frecuencia mínima semanal.
- Mantener una comunicación basada en la escucha activa y validación emocional.
- Evitar minimizar o invalidar el malestar emocional de la paciente.
- Establecer normas claras y consistentes, sin recurrir a dinámicas punitivas.
- Favorecer espacios de vínculo positivo y seguro.
- Supervisar cambios emocionales y conductuales.
- Realizar seguimiento constante del riesgo suicida.
- Implementar estrategias de activación conductual.
- Trabajar en regulación emocional y autoestima.
- Estar atentos a verbalizaciones relacionadas con muerte
- Aislamiento progresivo
- Cambios bruscos en conducta

Se sugiere implementar una **rutina diaria estructurada**, orientada a favorecer la organización conductual, la regulación emocional y el incremento de actividades reforzantes, la cual debe incluir:

- Responsabilidades escolares (tareas, estudio supervisado)
- Actividades del hogar acordes a la edad
- Espacios de actividad física o deportiva
- Tiempo de ocio regulado (dibujos, juegos, uso de pantallas con horarios definidos)
- Rutinas de sueño estables (horarios consistentes para dormir y despertar)

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU